Guía de la Actividad 4.1

La ficha de contexto sectorial: tendencias, dos casos reales verificados y la normativa que fija el calendario

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 4 — Transformación Empresarial y Roadmaps Arquitectónicos
Octubre de 2026

1. Qué pide la actividad

La Actividad 4.1 es **grupal** (a diferencia de la 3.1), formativa y sin nota; la retroalimentación se da en la sesión sincrónica con el F-36. Pide una **ficha de contexto sectorial de 1 a 2 páginas**: las tendencias de transformación digital del sector de la organización elegida, con **al menos dos casos reales** de organizaciones que hayan liderado procesos de transformación arquitectónica, citados en APA 7.

Para qué sirve después. La ficha no es un trabajo suelto: sus casos entran a la sección de casos de la Actividad 4.2, que se califica en el criterio «Gestión del cambio y casos sectoriales» (1,0). Allí cada caso tiene que **sostener una decisión del roadmap**. Busquen desde ya casos que se parezcan al problema de su organización, no los más famosos.

Una lente para leer los casos. Weill y Woerner (2018), capítulos 4 a 6, advierten que el error más común es empezar por la tecnología en lugar del modelo de negocio. Al leer un caso, pregúntense qué cambió en la forma de operar, no solo qué sistema se instaló.

2. Dónde buscar

Tipo de fuente	Ejemplos	Para qué sirve	Cuidado
Consultoras y revistas de gestión	Gartner, McKinsey, MIT Sloan Management Review, Harvard Business Review	Tendencias del sector y marcos para leerlas	Muchas piden suscripción; citen solo lo que pudieron leer
Reportes de las organizaciones	Informes anuales, memorias de sostenibilidad, sitios de prensa oficiales	Qué hizo la organización y en cuánto tiempo	Los resultados son autorreportados: díganlo
Publicaciones académicas	Revistas indexadas y actas de congresos del sector	Resultados medidos con método	Lean el resumen y los resultados, no solo el título
Certificaciones y acreditaciones	En salud, los niveles de madurez digital certificados por terceros	Evidencia externa de un avance	Verifiquen el año y si sigue vigente
Prensa sectorial de calidad	Medios especializados del sector	Hechos recientes y contexto local	Distingan la noticia del comunicado copiado
Normogramas oficiales	Ministerios, superintendencias, gacetas oficiales	La normativa que obliga y sus plazos	Verifiquen la vigencia el mismo mes en que escriben

3. Cómo se verifica un caso antes de citarlo

Paso	Qué hacer	Qué lo invalida
1 · Abrir la fuente	Llegar al documento o la página original y	Citar un resumen de buscador, un blog de

Paso	Qué hacer	Qué lo invalida
	leerlo.	un proveedor o una respuesta de una IA sin haber abierto la fuente.
2 · Comprobar lo que se afirma	Que la fecha, la cifra y el alcance dicen lo que ustedes escriben.	Una cifra que no aparece en la fuente, o que aparece para otra sede, otro año u otro indicador.
3 · Decir de dónde sale la cifra	Si la da la propia organización, es autorreportada. Si la mide un tercero, díganlo.	Presentar un resultado autorreportado como si fuera una evaluación independiente.
4 · Conectarlo con una decisión	¿Qué iniciativa, horizonte o rama del roadmap sostiene o pone en duda?	Un caso que no cambia ni sostiene ninguna decisión: es adorno.

> **Un caso que no se pudo verificar se descarta, aunque sea famoso.** Al preparar el ejemplo de Red Salud Andina se descartaron dos candidatos: uno porque no se encontró evidencia del nivel de madurez que se le atribuía, y otro porque dos fuentes secundarias daban niveles distintos y no se pudo abrir la primaria. Es mejor dos casos verificados que cinco dudosos.

4. El ejemplo: tres casos, cada uno con su decisión

Así quedó la parte de casos de la ficha de Red Salud Andina. Todas las fuentes se abrieron en septiembre de 2026.

Caso	Qué hizo	Resultado y quién lo reporta	Decisión del roadmap que sostiene
Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Internacional de Colombia (Bucaramanga)	Historia clínica electrónica propia (SAHI) integrada con laboratorio, imágenes, patología y farmacia; después, uso del dato: alertas tempranas con IA y telemonitoreo	HIMSS EMRAM 6 en 2021 y 7 en 2022; recertificación EMRAM 7 en enero de 2026, única institución colombiana con ese nivel vigente (Moreno González, 2026)	El orden de T+1 a T+2: primero se integran los sistemas satélite a una sola historia (D2, A4, A6) y solo después se explota el dato (D4)
Mayo Clinic, Plummer Project (Estados Unidos)	Reemplazó sistemas dispares por una sola historia clínica y un solo sistema de ciclo de ingresos, en 90 hospitales y clínicas	Despliegue por olas regionales entre julio de 2017 y octubre de 2018; la misma información del paciente en cualquier sede y un estado de cuenta consolidado (HMT, 2018)	La rama B: si se consolida, se hace por oleadas de dos sedes y con historia y facturación juntas, no con un corte único
Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina)	Sistema de información propio desde 1998, integrado con admisiones, laboratorio y radiología mediante HL7; en 2001 creó un departamento de informática en salud de más de 110 personas	Veinte años de construcción sostenida; su índice maestro de pacientes se adapta a necesidades de registro nuevas sin rehacer el sistema (Frangella et al., 2019; International Medical Informatics Association, 2015)	K1 y el índice maestro primero: la capacidad interna y la identidad única son lo que permite crecer después; y la humildad del horizonte: 36 meses no alcanzan para todo

5. La normativa que fija el calendario

En salud, varias de las fechas del roadmap no las pone la organización sino la norma. Esta tabla se verificó en las fuentes oficiales en septiembre de 2026.

Norma	Entidad	Qué establece	A quién obliga	Plazo y vigencia

Norma	Entidad	Qué establece	A quién obliga	Plazo y vigencia
Ley 2015 de 2020	Congreso	Crea la historia clínica electrónica interoperable	Prestadores públicos y privados	Obligatoria; el plan de implementación de 5 años venció en enero de 2025
Resolución 866 de 2021	MinSalud	Elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad	Prestadores y demás actores del sistema	Obligatoria; es la base del contenido del RDA
Resolución 1888 de 2025	MinSalud	Adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)	Actores del artículo 2 de la Resolución 866	Plazo de 6 meses desde el 15 de octubre de 2025: **venció el 15 de abril de 2026**. Modificada por la Resolución 1799 de 2026
Resolución 2275 de 2023	MinSalud	RIPS como soporte de la factura electrónica de venta en salud	Prestadores de servicios de salud	Obligatoria; con la Resolución 1884 de 2024, en operación para mediana complejidad desde el 1 de febrero de 2025
Resolución 1644 de 2026	MinSalud	Requisitos de la telesalud y la telemedicina; deroga la Resolución 2654 de 2019	Prestadores con telemedicina	Vigente desde el 31 de julio de 2026: interoperabilidad y sin duplicidad de registros (art. 14)
Ley 1581 de 2012	Congreso	Protección de datos personales; los datos de salud son sensibles	Toda organización que trate datos personales	Obligatoria

Un plazo vencido no es un riesgo futuro: es un incumplimiento presente. El plazo del RDA venció el 15 de abril de 2026; si ningún sistema de su organización lo produce, la iniciativa va en T+0, no en T+1. Y la normativa cambia: hace tres meses, citar la Resolución 2654 de 2019 para telemedicina era correcto; hoy está derogada. Si su organización es de otro sector —banca, gobierno, servicios—, identifiquen la normativa de su sector y verifiquen su vigencia en el normograma oficial.

6. Cómo se ve bien hecho

Campo	Así no	Así sí	Por qué
Tendencia	«La transformación digital avanza en el sector salud»	«La historia clínica interoperable es obligatoria (Ley 2015 de 2020) y el RDA tenía plazo hasta el 15 de abril de 2026»	Una tendencia se sostiene con un dato y una fuente.
Caso	«Mayo Clinic es un referente en transformación digital»	«Mayo Clinic consolidó historia clínica y facturación en un solo sistema, por olas regionales, entre 2017 y 2018»	Dice qué hizo y en cuánto tiempo.
Conexión	El caso termina en sí mismo	«…por eso, si se consolida (rama B), se hace por oleadas de dos sedes»	El caso tiene que sostener una decisión.
Cifra	«Redujo 20 % los eventos adversos»	«Reportó una reducción del 20 % (cifra autorreportada)»	El lector tiene que saber quién la mide.

Referencias

Colombia, Congreso de la República. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Colombia, Congreso de la República. (2020). *Ley 2015 de 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable*.

HMT. (2018, 10 de octubre). *Mayo Clinic completes installation of Epic electronic health record*. Healthcare Innovation. https://www.hcinnovationgroup.com/clinical-it/electronic-health-record-electronic-medical-record-ehr-emr/article/13010956/mayo-clinic-completes-installation-of-epic-electronic-health-record

International Medical Informatics Association. (2015). *Hospital Italiano de Buenos Aires*. https://imia-medinfo.org/wp/hospital-italiano-de-buenos-aires/

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). *Resolución 866 de 2021*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). *Resolución 2275 de 2023*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). *Resolución 1884 de 2024, por la cual se modifica la Resolución 2275 de 2023*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). *Resolución 1888 de 2025, por medio de la cual se adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)*.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2026). *Resolución 1644 de 2026, por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la telesalud y la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina*.

Moreno González, N. (2026, 21 de enero). *HIMSS recertifica al HIC en EMRAM 7: así sostiene el liderazgo en salud digital en Colombia*. ConsultorSalud. https://consultorsalud.com/himss-recertifica-al-hic-en-emram-7-salud/

Weill, P., & Woerner, S. L. (2018). *What's your digital business model? Six questions to help you build the next-generation enterprise*. Harvard Business Review Press.